11.7.1. 재난관리체계

제 정 일	2014.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	재난대응위원회				
유 관 부 서	환자안전팀				

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 11.7 재난관리체계 JCI Standard 7th Edition: FMS.11

제1조 (목적)

1. 재난 발생 시 환자, 보호자, 직원 및 방문객 안전을 도모하고 재난으로 인한 손상과 피해를 최소화하기 위해 국가, 지역사회, 의료기관 등에서 발생 가능성이 높은 응급재난을 파악하고 대비책 마련 및 훈련을 수행한다.

제2조 (정의)

1. 재난: 국민의 생명 · 신체 · 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음과 같이 분류한다.
   1) 자연재난: 태풍, 홍수, 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사 등 자연현상으로 인하여 발생하는 재해
   2) 사회재난: 지역사회 화재, 붕괴, 폭발, 의료기관의 물 및 전기공급 차단, 전산장애, 외부통신회선 사고로 인한 건강보험자격조회 등 시스템 접근 불가 등
2. 재난관리: 재난의 예방 · 대비 · 대응 및 복구를 위하여 하는 모든 활동

제3조 (절차)

1. 재난관리 계획
   1) 재난대응위원회는 병원과 지역사회 내에서 발생가능성이 높은 재난 유형 파악하고 내·외부 재난에 대응하기 위한 재난관리 계획을 매년 수립한다.
   2) 재난관리 계획에는 다음 내용을 포함한다.
      (1) 재난의 유형, 가능성과 위험, 위협, 재난사고의 영향 결정
      (2) 재난 시 의료기관의 역할 결정
      (3) 재난 발생 시 의사소통 전략 수립
      (4) 예비 자원을 포함하여 재난 기간 동안 자원관리 계획 수립
      (5) 대안적 진료장소를 포함하여 재난 기간 동안 임상 활동의 관리 계획 수립
      (6) 재난 기간 동안 직원의 역할 및 책임 부여, 배치 계획 수립
      (7) 직원의 개인적 책임이 환자 진료 인력 구성을 위한 의료기관의 책임과 갈등이 있는 경우 응급상황 관리하는 절차 수립
   3) 위험 취약도 분석
      (1) 재난위험성을 평가하기 위하여 연간 HVA(Hazard Vulnerability Analysis)를 이용하여 재난상황의 우선순위를 선정하며 그 결과를 시설안전관리위원회에 연 1회 보고한다.

(2) HVA는 모든 잠재적 발생 가능성이 있는 상황에 대하여 발생 가능성, 위험도, 준비 정도에 대하여 각 상황 별 점수를 매기고 그 총점이 높은 순위별로 우선순위를 선정하는 방식으로 이루어진다.

2. 재난관리

1) 재난 신고 및 활성화

(1) 재난발생을 인지한 부서(교직원)에서는 응급진료센터로 재난 발생신고를 한다.

(2) 병원 외부 재난 발생에 대해 응급진료센터장은 재난단계에 따른 재난 활성화 계획을 병원장에게 보고한다.

(3) 병원장은 재난의 단계를 결정한 후 재난대책본부 소집을 결정한다.

2) 재난 시 의료기관 내(외)부 의사소통: 재난 시 비상연락망[그림1]에 따른다.

[그림1. 재난 시 비상연락망]

3) 재난대책본부의 구성 및 역할

(1) 재난 발생 시 재난대책본부[그림2]를 운영한다.

① 세브란스병원장은 모든 재난대책의 총괄책임자인 재난대책위원장으로서 재난대책위원회를 소집하고 지휘한다.

② 응급진료센터장은 재난에 대한 의료관리의 주체이며 재난대책본부의 운영위원장 역할과 진료총괄의 책임을 갖는다.

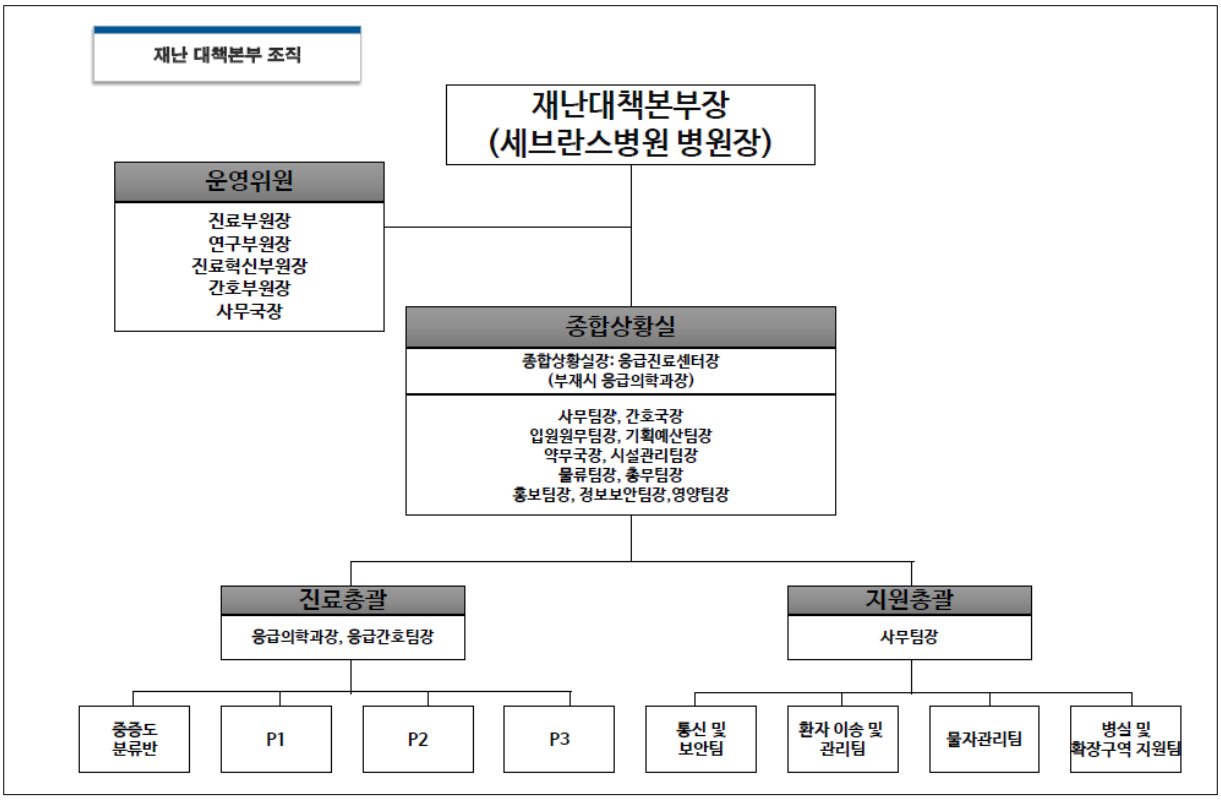
③ 사무국장은 재난에 대한 행정관리의 주체이며 운영본부의 지원총괄 책임을 갖는다.

(2) 재난대책본부의 역할

a. 재난상황에 따른 관련부서(팀)장의 비상소집, 현장 대응조치, 지원에 관한 정책을 결정한다.

b. 재난 대응 상황을 감독하며 진행 상황을 지휘한다.

c. 재난사고와 진행 결과에 대한 정보의 수집, 관리 및 대내 · 외 발표를 주관한다.



[그림2. 재난대책본부 업무 기구표]

4) 환자진료

(1) 재난 준비단계

① 진료활동과 대체 진료 장소를 조정한다.

② 진료구역을 설치한다.

③ 각 구역에 필요한 인력을 배치하고 각 인력의 업무를 명확히 하며 업무가 적시 적절하게 진행되는지 모니터링 한다.

(2) 응급진료센터 진료단계

① 중증도 분류 전에 필요 시 선별 혹은 제염·제독을 실시한다.

② 중증도 분류를 실시하고, 환자마다 고유번호 및 전산 접수용 이름을 부여한다.

③ 분류된 환자는 해당 진료구역으로 이송 후 진료한다.

(3) 의료기기 및 물품 확보: [부록1. 세브란스병원 재난대책 지침]에 따라 관련 부서는

의료기기 및 물품을 확보한다.

5) 재난상황 종료

(1) 재난상황 종료는 진료총괄인 응급진료센터장이 건의하여 재난대책본부의 판단 하에 이루어진다.

(2) 재난대응에 대한 전반적인 평가를 실시하고 문제점과 개선안에 대한 보고서를 작성하고 시설안전관리위원회에 보고한다.

3. 모의훈련 수행 및 관리

1) 모의훈련은 환자안전팀이 주관하고 모의훈련 주제에 따라 관련부서가 참여한다.

2) HVA(Hazard Vulnerability Analysis)결과 등을 참고하여 모의훈련 계획을 수립한다.

3) 병원 내 · 외 재난 발생에 대비한 모의훈련을 내부적으로 또는 지역사회 차원에서 적어도 연 1회 이상 실시한다. 지역사회 유관기관에서 훈련에 참관할 수 있도록 한다.

4) 모의훈련은 원내 상황에 따라 도상훈련(회의실이나 한 공간에서 도구나 부호를 이용하여 실제 상황처럼 구상해보는 방법)으로 실시할 수 있다.

5) 훈련내용: 재난 시 의사소통, 자원관리를 포함하여 진행한다.

6) 디브리핑 등을 이용하여 모의훈련 수행 결과 및 효율성을 평가하고 평가결과에 따라 취약부분에 대한 개선방안을 수립하고 적용한다. 관련 사항은 문서로 기록하고 시설안전관리위원회, 병원운영위원회에 보고한다.

7) 개선(안)은 차기년도 재난대비 계획 수립에 반영한다.

제4조 (부록)

1. 세브란스병원 재난대책 지침

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2014년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)